

Autoconsciencioterapia das Predisposições à Belicopensenidade Autodefensiva

*Autoconsciencioterapia de las Predisposiciones a la Belicopensenidad
Autodefensiva*

*Self-Conscientiotherapy of Predispositions to Self-Defensive
Bellicothosenity*

Maximiliano Haymann

Consciencioterapeuta, psicólogo, engenheiro, mestre em Engenharia Biomédica, voluntário da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), maximilianoth@gmail.com

RESUMO. Neste trabalho investigou-se a belicopensenidade manifesta como reação defensiva diante da percepção da ameaça de perda de algum tipo de poder. A autoinvestigação da parapatologia iniciou pela identificação do mal-estar causado pela emoção de raiva e autoconstrangimento cosmoético. Apresenta-se um modelo para a parapatofisiologia da belicopensenidade, no qual se fundamentou a autoinvestigação e a aplicação das técnicas de checagem holossomática e de registro dos autopenes. A análise das distorções cognitivas, crenças regressivas, valores e intenções patológicos mostraram as raízes intraconscienciais impulsionadoras da reatividade conflitiva, assentadas na tendência de estabelecer confrontos de poder nas inter-relações. A paraterapêutica foi realizada por meio da desconstrução da belicopensenidade e da qualificação da compreensão fraterna. Foram estabelecidos 14 indicadores de autossuperação. Conclui-se que a aplicação das técnicas resultou na redução da belicopensenidade, contudo ainda há necessidade de maior detalhamento do autodiagnóstico e da ampliação da experimentação do autoenfretamento.

Palavras-chave: raiva; irritação; poder; belicismo; fraternidade; compreensão fraterna.

RESUMEN. En este trabajo se investigó la belicopensenidad manifesta como reacción defensiva ante la percepción de la amenaza de la pérdida de algún tipo de poder. La autoinvestigación de la parapatología se inició a través de la identificación del malestar causado por la emoción de la rabia y el autoconstreñimiento cosmoético. En este artículo se propone un modelo para la parapatofisiología de la belicopensenidad, en la cual se fundamenta la autoinvestigación, la aplicación de las técnicas de chequeo holosomático y el registro de los autopenes. El análisis de las distorsiones cognitivas, creencias regresivas, valores e intenciones patológicos muestran las raíces intraconscienciales impulsoras de la reactividad conflitiva, asentadas en la tendencia de establecer enfrentamientos de poder en las interrelaciones. La paraterapéutica fue realizada por medio de la desconstrucción de la belicopensenidad y de

la cualificación de la comprensión paterna. Fueron establecidos 14 indicadores de autosuperación. Se concluyó que la aplicación de las técnicas resultó en la reducción de la belicopen-senidad, sin embargo todavía existe la necesidad de mayor detalle del autodiagnóstico y de la ampliación de la vivencia del autoenfrentamiento.

Palabras clave: rabia; irritación; poder; belicismo; fraternidad; comprensión fraterna.

ABSTRACT. This article investigated bellicothosenity manifested as a defensive reaction to the perception of the threat of some power loss. The self- investigation of the parapatology started by the identification of the malaise caused by the emotion of anger and cosmoethical self-embarrassment. It presents a model of the parapatophysiology of bellicothosenity, which was based on self-investigation and application of techniques of holosomatic check-up and registration of self-thosenes. The analysis of cognitive distortions, regressive beliefs, values and pathological intentions showed the intraconsciential roots driving the conflictive reactivity, settled in the tendency to promote power clashes in the inter-relations. The paratherapy was performed by the deconstruction of the bellicothosenity and the qualification of fraternal understanding. 14 indicators of self-overcoming were established. The conclusion is that the application of techniques resulted in reduced bellicothosenity, however there is still a need for a more detailed self-diagnosis and expansion of the self-confrontation experimentation.

Keywords: anger; irritation; power; warmongering; fraternity; fraternal understanding.

INTRODUÇÃO

Dominação. O poder impositivo, anticosmoético, aparece nas relações interconscienciais quando alguma das partes procura fazer prevalecer a vontade pessoal autocrática sobre a manifestação alheia.

Mecanismos. Diferentes mecanismos são usados para a dominação interconsciential, entre eles: a manipulação, a sedução energética e o uso de algum tipo de força (Young, 2008), este último, chamado de poder coercitivo, quando a raiva e a agressividade estão mais presentes nas interações.

Escala. A manifestação da agressividade contra outra consciência varia numa escala na qual no extremo patológico encontra-se a violência física e de inúmeras outras formas, mais ou menos ostensivas, a ameaça verbal, o gestual ameaçador, o xingamento, a heterocrítica ácida, o sarcasmo, a ironia e a própria exteriorização silenciosa de energias conscienciais (ECs) patológicas para outrem.

Belicopense. Pela ótica da *Evoluciologia*, tanto a violência física quanto os outros diferentes tipos de agressividade demonstram a sujeição da conscin agressora ao subcérebro abdominal e a presença da belicopen-senidade na intraconscientialidade (Bello, 2010; Vieira, 2007).

Resquícios. A existência de resquícios de belicismo na paragenética pode ser exemplificada pela conduta da conscin que apresenta trato cordial nas inter-relações cotidianas, sendo inclusive frontalmente contrária a qualquer tipo de violência física; porém, quando experencia situações em que percebe a ameaça da perda de algum tipo de poder real ou imaginário (Lipp & Malagris, 2013), reage agressivamente, regressando ao *modus operandi bellicosus* para se defender ou se impor.

Foco. No presente trabalho é dado enfoque na autoconsciencioterapia para a remissão das autopredisposições da belicopen-senidade autodefensiva, na qual a raiva e agressividade não resultam em violência física, mas são expressões de hostilidade antagônica à vivência da intercompreensão e da fraternidade.

CFC. Esta autopesquisa foi desenvolvida durante o Curso para Formação do Consciencioterapeuta (CFC) da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), ocorrido entre outubro e dezembro do ano de 2015.

Fontes. A pesquisa bibliográfica concentrou-se em publicações especializadas sobre Autoconsciencioterapia, raiva, agressividade, assertividade e temas correlatos das ciências Conscienciologia, Psicologia e Psiquiatria.

Metodologia. A metodologia de pesquisa fundamentou-se na autoexperimentação das técnicas da Autoconsciencioterapia e em observações livres da manifestação de conscins do círculo social que apresentam padrão de comportamento similar.

Organização. O presente artigo foi dividido em 7 seções, dispostas a seguir na ordem lógica de apresentação:

- I. **Parapatofisiologia da Belicopen senidade Autodefensiva.**
- II. **Belicopen senidade.**
- III. **Autoassédios Latentes.**
- IV. **Paraterapêutica.**
- V. **Desenvolvimento da Compreensão Fraternal.**
- VI. **Indicadores de Autossuperação.**
- VII. **Conclusão.**

I. PARAPATOFISIOLOGIA DA BELICOPEN SENIDADE AUTODEFENSIVA

1.1. *Técnica de Identificação do Mal-estar*

Autoinvestigação. A partir da *técnica de identificação do mal-estar* foram observados o desconforto emocional, causado pela raiva, e o autoconstrangimento cosmoético, advindo da percepção da automanifestação agressiva contra outrem.

Incoerência. Também foi relevante para o movimento autoconsciencioterápico a constatação da incoerência da manifestação pessoal ocorrida em tais contextos, por ser contrária ao valor pessoal, cosmoético, da interassistencialidade.

Contextualização. Deste modo, fez-se necessária a compreensão da parapatofisiologia desta modalidade de reação belicista, na qual está insita a emoção de raiva e a percepção de ameaça ou desafio de poder, de modo a identificar, com maior detalhamento, como e quais predisposições intraconscienciais desencadeiam a belicopen senidade.

1.2. Modelo da Parapatofisiologia da Belicopen senidade Autodefensiva

Básica. A raiva é uma das emoções básicas das conscins e, ao lado da tristeza e do medo, é considerada como afeto negativo, diferente da alegria, o protótipo da emoção positiva.

Definição. Segundo a *American Psychological Association* (APA), a raiva é uma emoção caracterizada por tensão e hostilidade originadas de fontes como frustração, ataque real ou imaginado por parte de outra pessoa ou injustiça percebida.

Desconforto. Lipp & Malagris (2013), especialistas no tema, definem a raiva como um sentimento de intenso desconforto resultante da percepção de alguma provocação, seja ela uma ofensa, um desacordo, mau tratamento, rejeição, agressão, frustração ou desmerecimento por parte de alguém ou de alguma entidade.

Ataque. Para as autoras, o sentimento de desconforto causado pela raiva pode ser tão intenso que leva a pessoa a querer revidar e atacar quem supostamente a enraiveceu.

Resposta. Tendo em vista as duas definições anteriores, o mecanismo básico da resposta de raiva e da consequente manifestação agressiva pode ser descrito da seguinte forma:

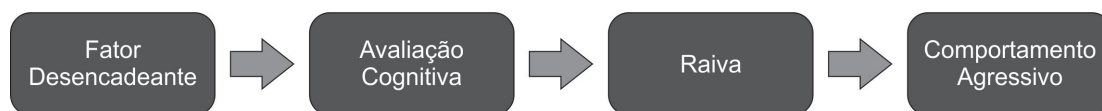


Figura 1. Modelo cognitivo da reatividade agressiva.

Normose. Os pesquisadores da ciência convencional alegam ser normal, não patológico, a pessoa sentir raiva em determinados contextos, diferenciando-a, destarte, da raiva patológica, esta sim causadora de danos ou prejuízos ao funcionamento sadio do indivíduo.

Divergência. Contudo, pela ótica da *Evolucilogia*, quaisquer emoções de raiva, mesmo aquelas consideradas normais, ainda representam vestígios da subumanidade na intraconsciencialidade, possuindo raízes baratroféricas. Para Vieira (2014), a raiva é sentimento belicoso que pode ser substituído, com enormes vantagens, pela autocompreensão evolutiva.

Modelo. Tendo em vista a *Pensenologia*, a raiva é apenas 1 dos elementos da pensenidade patológica da conscin hostil. Desta forma, a parapatofisiologia da belicopensenidade autodefensiva pode ser melhor representada por intermédio do *Ciclo do Autoassédio*, proposto por Haymann (2014):

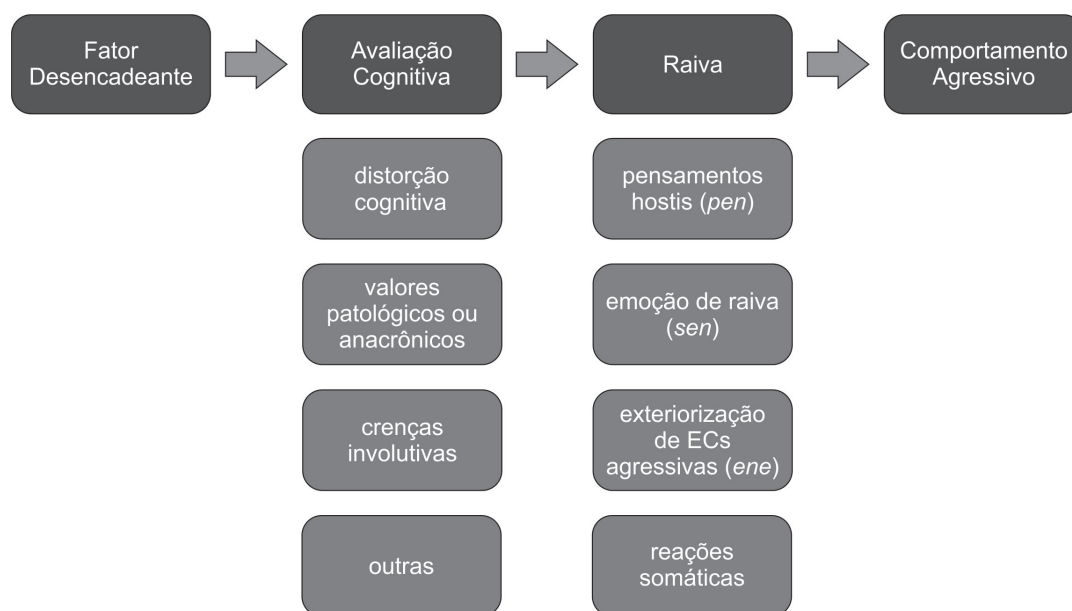


Figura 2. Modelo da parapatofisiologia da belicopensenidade autodefensiva.

II. BELICOPENSENIDADE

2.1. Elementos da Belicopensenidade

Reação. Tendo em vista a *Somatologia*, a resposta de raiva se dá pela ação neuroendócrina da reação de luta ou fuga (*flight-or-fight reaction*) diante de uma ameaça, deixando a pessoa mais energizada e preparando o corpo físico para as referidas reações.

Significação. Dividimos com os subumanos esse modo de reação, mas entre os seres humanos a significação dada a determinada situação ameaçadora é mais variada e complexa. A pessoa pode

sentir-se ameaçada por um suposto ataque à autoimagem, à autoestima, entre outros aspectos ainda mais subjetivos, e a partir desta cognição desencadear a reação defensiva ou de contra-ataque.

Fisiologia. Quando o mecanismo é ativado, ocorre a secreção adrenal de epinefrina levando ao aumento da frequência cardíaca, do fluxo sanguíneo para o cérebro e para os músculos, bem como à elevação dos níveis de açúcar no sangue. Na periferia somática, as palmas das mãos e solas dos pés ficam suadas, as pupilas dilatadas e os pelos se eriçam.

Fácies. Ao sentir raiva, a pessoa normalmente exibe expressões faciais típicas, por vezes caricatas, como o franzimento das sobrancelhas, a dilatação das narinas e os lábios cerrados; mesmo se tentar manter o controle voluntário destas, será pouco provável ocultar algumas microexpressões faciais, ao modo do pequeno aperto nos lábios que costuma aparecer quando sobrevém a raiva.

Semipossessão. As expressões faciais ainda podem servir de elemento diagnóstico para a semipossessão maligna, relativamente frequente entre aqueles que experimentam o estado raivoso. As mudanças faciais, não raro, denotam a interfusão pensênica momentânea maior entre a conscin sem higiene consciencial e a consciex assediadora.

Heteroassédio. A partir da afinidade da pensenidade carregada no *sen*, as consciexes mal-intencionadas intensificam a sensação de poder e de energização do próprio mecanismo fisiológico da conscin raivosa, aproveitando para vampirizar energias, criar e fortalecer conflitos intra e interconscienciais.

Emoção. Pela *Psicossomatologia*, a estimulação de centros cerebrais que regulam as emoções na reação de raiva reduz a lucidez e o autodiscernimento, solapando a capacidade pessoal de raciocínio.

Energias. Pelos princípios da *Energossomatologia*, mesmo quando a conscin raivosa não age nem se comunica agressivamente, suas ECs hostis são exteriorizadas e facilmente perceptíveis por outras conscins com sensibilidade parapsíquica. A pessoa irritadiça tende a ter o umbilicochakra e o cardiochakra bloqueados e descompensados.

Assédio. Conclui-se que a raiva, manifestada fisicamente ou não, se configura em algum tipo de agressão ou, de modo mais amplo, assédio, capaz de intoxicar emocional e energeticamente a própria conscin raivosa e a pessoa alvo da ira.

Concretização. A materialização do ato agressivo é o auge patológico da manifestação de raiva, daí seguem todos os tipos de violências, crimes e guerras.

Hostilidade. Segundo a *Mentalsomatologia*, ampla gama de pensamentos hostis e efeitos negativos sobre os atributos mentaisomáticos sobrevêm, conforme pode ser observado pelos resultados obtidos pela aplicação das técnicas da checagem holossomática e a de registro dos autopensenes, apresentadas a seguir.

2.2. Técnica da Checagem Holossomática Paradiagnóstica

Holossomatologia. Tendo em vista a autoinvestigação, eis as reações holossomáticas associadas à belicopensenidade, identificadas por este autor em si próprio, surgidas em diferentes contextos e com frequência variável:

1. **Soma:** fixação do olhar; abaixamento das sobrancelhas; aumento do tom e engrossamento da voz; postura física de alerta e de enfrentamento; calor; sensação de força; impulso físico de reagir e revidar; taquicardia; leve dor de cabeça no lobo parietal direito.

2. **Psicossoma:** sentimentos de raiva, frustração, indignação e injustiça; rebaixamento do humor; coragem; descompensação do cardiochakra e do umbilicochakra.

3. **Energossoma:** exteriorização de ECs agressivas; autointoxicação energética; reforço externo de energias; bloqueio cortical.

4. **Mentalsoma:** redução do autodiscernimento, da autolucidez e da capacidade de avaliação crítica da situação; concentração; hipercriticidade acrítica; pensamento fixo na situação; pensamentos antagônicos; pensamentos de desqualificação alheia; foco no heterotrafar; pensamentos de retaliação e vingança.

Sinaleticologia. Na prática da checagem holossomática é importante ficar alerta para as sinérgicas parapsíquicas, sinais físicos e indicadores da ação de consciêxas patológicas reforçando a belicopensenidade, como indicam, por exemplo, dores de cabeça, bloqueios corticais e a desqualificação da autopenalidade.

2.3. Técnica do Registro dos Autopenidades

Autoinvestigação. Para a investigação do autoassédio manifesto ou, especificamente, da belicopensenidade autodefensiva, foi aplicada a *técnica do registro dos autopenidades*. Eis, por exemplo, 5 situações ilustrativas de sua aplicação:

Tabela 1. Registro dos autopenidades.

Situação	Pensamentos antagônicos	Emoções / sentimento	Energias / comportamentos	Materpensene
Assistindo a aula considerada enfadonha.	Essa aula é uma perda de tempo, já sei tudo isso aí. Estão me fazendo perder tempo.	Ansiedade, impaciência, raiva.	Fala que a aula está sendo perda de tempo, pois já sabe o conteúdo; agitação psicomotora, taquicardia.	Apropriação indevida do tempo por outrem.
O professor chama minha atenção em frente a todos na sala de aula.	Ele está me humilhando ao falar assim comigo na frente de todos. Não vou aceitar isso.	Vergonha, raiva.	Dissimula a vergonha, assume posição pensinica defensiva e discorda do professor com agressividade.	Desrespeito.
A secretária não compra a passagem aérea na data solicitada e o preço aumenta.	Devia ter feito o que eu pedi, eu estava certo, ela me causou prejuízo.	Raiva.	Chama a atenção da secretária pelo erro de modo acusador, exteriorização de ECs negativas, leve dor de cabeça.	Prejuízo.
Não é chamado para o cargo almejado.	Eles não reconhecem o meu valor e tudo o que eu já fiz. Isto está errado.	Raiva, mágoa, tristeza.	Desqualifica o cargo e os líderes que não o convidaram para a posição.	Desmerecimento Injustiça.
Interage com alguém que se comporta de modo arrogante.	Ela se acha superior a mim e me trata como se eu fosse inferior. Quem ela pensa que é? Vou trata-la de modo igual.	Aversão, raiva.	Critica a pessoa para outras, se afasta do convívio com a pessoa.	Ataque à Autoimagem.

ECs. Mesmo que não seja percebida, a belicopensenidade acompanha a exteriorização de ECs patológicas carregadas no *sen* contra aqueles com os quais há alguma interação conflitiva, bem como a descompensação do cardiochakra e rebaixamento da autolucidez.

Significação. O item *materpensene* do caso depende da interpretação dada pela conscin à situação experienciada; é o tema central da cognição quanto aos fatos e parafatos vivenciados.

Poder. Conforme as bibliografias de Lipp (2010) e Young (2008) indicam, tais cognições sugerem um viés pensênico de avaliar a ação e a intenção de outras conscins como algum tipo de provocação, desafio ou ameaça ao poder pessoal.

2.4. Efeitos Patológicos da Belicopensenidade

Consequências. Este *modus operandi bellicosus* gera uma série de efeitos nosológicos, antifraternos, tanto para as conscins e consciexes do círculo de relações pessoais, quanto para a própria conscin agressiva.



Figura 3. Efeitos patológicos da belicopensenidade.

Heteroassediologia. Pela ótica da *Maxifraternologia*, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 11 efeitos patológicos passíveis de serem causados na convivialidade ou diretamente na manifestação alheia quando a conscin reage movida pela belicopensenidade para defender algum tipo de poder ou impor a vontade pessoal:

01. **Afastamento.** Afastamento das pessoas do convívio pessoal.
02. **Conflitividade.** Criação de conflitos e discussões evitáveis por onde passa.
03. **Contrapenses.** Estímulo de bilipenses ou contrapenses patológicos nos outros, especialmente naquelas consciências com tendência igualmente belicista.
04. **ECs.** Intoxicação das conscins-alvos da ira com as ECs patológicas.
05. **Holopense.** Piora do holopense ambiental multidimensional por onde se manifesta.
06. **Inautenticidade.** Incentivo às conscins do círculo de convivência, principalmente aquelas mais próximas, a se portarem perante si com inautenticidade e dissimulação, ocultando opiniões contrárias para evitar confronto.
07. **Inimizades.** Criação de inimizades de modo desnecessário.
08. **Intimidação.** Intimidação das companhias pessoais, fazendo-as sentirem-se apreensivas ou mesmo temerosas.
09. **Rebaixamento.** Desencadeamento de sentimentos de inferioridade e humilhação nas personalidades mais suscetíveis.
10. **Ressentimento.** Criação de rastro indigno de sentimentos de raiva, mágoa, rancor nos outros.
11. **Submissão.** Induz as companhias pessoais a assumirem posturas submissas e subservientes para evitar o conflito.

Autoassediologia. Sob a ótica da *Trafarologia*, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 11 possíveis consequências patológicas contra a própria conscin, quando habituada a reagir movida pela belicopensenidade para defender algum tipo de poder ou impor a vontade pessoal:

01. **Algoz.** Assunção da posição indigna de algoz e dominador de outra consciência.
02. **Antipatía.** Enceguecimento emocional para as necessidades das pessoas ao redor.
03. **Assédio.** Atração de companhias extrafísicas doentias afinizadas com tal padrão patopen-sênico.
04. **Autorregressão.** Manifestação pessoal regredida, ao modo do animal subumano movido por emoções atávicas.
05. **Crueldade.** Comportamento hostil e, até mesmo, cruel.
06. **Desamparo.** Perda da conexão pensênica e, conseqüentemente, da assistência dos amparadores extrafísicos.
07. **Grupocarmologia.** Piora do saldo da conta corrente grupocármica pessoal.
08. **Intoxicação.** Intoxicação com as próprias energias patológicas, não raro potencializadas pelas energias dos assediadores.
09. **Lucidez.** Redução do autodiscernimento e da autolucidez
10. **Ressentimento.** Sentimento de mágoa, ressentimento e até depressão em situação nas quais não pode expressar a própria raiva e conseguir o que deseja.
11. **Xenopenses.** Fornecimento de permissão tácita às intrusões pensênicas patológicas, desencadeando o heteroassédio.

Conduta. Ao ver o mundo e as pessoas como desafiadoras e ameaçadoras do poder pessoal, a conscin pode desenvolver espécie de conduta armada contínua (Vieira 2013), autodefensiva, colocando-se, preventivamente, física e pensenicamente, a postos para fazer frente a qualquer possível ataque externo.

Antagonismo. Tal postura difere diametralmente da autodefesa energética interassistencial, pois é eminentemente belicosa e visa o contra-ataque, desta forma sustentando holopensene intimidador e atrator de consciex de padrão semelhante, reforçadora da sensação de força e de segurança para a conscin, sensação esta, contudo, de natureza bélica.

2.5. Problematização.

Autoinvestigação. Tendo em vista a *Autoconsciencioterapia*, eis 2 questionamentos para o aprofundamento da compreensão das autopredisposições à belicopensenidade:

1. **Poder.** Por que determinadas situações são avaliadas de maneira distorcida, sendo consideradas ameaça, provocação ou desafio a algum tipo de poder pessoal? Como enfrentar e superar esta condição?
2. **Belicismo.** Mesmo se todas essas avaliações de ameaça correspondessem à realidade, por que o modo de reação ou a estratégia de enfrentamento pessoal é de ataque ou contra-ataque às outras pessoas? Como enfrentar e superar esta condição?

III. AUTOASSÉDIOS LATENTES

Latentes. Para avaliar a etiologia da belicopensenidade autodefensiva em análise, foram selecionados 4 tipos de autoassédios latentes das 18 categoriais citadas por Haymann (2014), conforme disposto a seguir:

3.1. Distorções Cognitivas.

Autoassédios. Os itens da coluna materpensene da tabela da *técnica de registro dos autopen-senes* trazem os significados pessoais auferidos a partir de ações de outras conscins:

1. **Tempo.** O *outro* se apropriou indevidamente do meu tempo.
2. **Desrespeito.** O *outro* me tratou com desrespeito.
3. **Prejuízo.** O *outro* me causou prejuízo.
4. **Desmerecimento.** O *outro* me desmereceu.
5. **Ataque.** O *outro* atacou a minha autoestima.

Tendenciosidade. Os exemplos anteriores indicam haver análise tendenciosa do comportamento de outras conscins, consideradas reiteradamente como provocadoras, desafiadoras, ameaçadoras e com a intenção negativa de atacar e causar algum tipo de prejuízo.

Monovisão. A redução do autodiscernimento pode ser constatada pela avaliação monovisiológica, devida à tendência de atenção seletiva somente às pretensas ameaças ao ego, não percebendo outras variáveis presentes no contexto.

Exemplologia. Eis, na ordem da listagem do registro de autopen-senes, 5 diferentes distorções cognitivas da realidade, autoassédios mentaisomáticos, sustentadores da belicopensenidade autodefensiva:

1. **Personalização:** durante a aula avaliada como enfadonha, não foi levada em conta a possibilidade de aquelas informações serem relevantes para si e para as demais conscins ali presentes, denotando autocentrismo patológico e consequente desconsideração das necessidades alheias.

2. **Abordagem monovisiológica:** no caso da reprimenda pública, o foco pessoal foi direcionado para o sentimento de humilhação, minimizando o *feedback* do professor e o próprio comportamento monopolizador, fato denunciador da manifestação egoica e dominadora neste contexto.

3. **Atitude *deveria*:** no exemplo em que a secretária não pôde comprar a passagem, a autopen-senidade foi dominada pelas emoções advindas da percepção de se ter sido prejudicado. Não houve empatia, pois não foi considerada a hipótese de ela ter tido dificuldades para fazer a compra, de estar também chateada por não tê-la realizado.

4. **Supergeneralização:** quando não foi chamado para o cargo pretendido e considerado merecido, julgou exageradamente que nada do que havia feito até então era valorizado e reconhecido.

5. **Raciocínio emocional:** na interação com a conscin arrogante não foi capaz de compreender fraternalmente tal conduta como reflexo da parapatologia alheia, apenas reagindo à raiva por se sentir destrutado.

Irrracionalidade. Importante ressaltar o forte componente emocional presente nas situações elencadas, pois a interpretação de ataque, dano ou prejuízo pessoal elicia a belicopensenidade, restringindo o autodiscernimento e diminuindo ainda mais a capacidade já comprometida de compreender fraternalmente os outros e atribuir significados mais positivos para as situações vivenciadas.

3.2. Crenças Regressivas.

Exemplologia. Eis, por exemplo, 10 crenças regressivas, divididas em favorecedoras de posturas belicistas preventivas e autodefensivas:

A. Desencadeadoras de posturas autodefensivas preventivas:

01. Não vou ficar me rebaixando para os outros.
02. Não vou me aproximar de quem me trata mal ou me desconsidera.
03. Não vou me deixar assistir, pois estar na posição de assistido é sinal de que sou inferior a quem me assiste.
04. Não vou mostrar erros, fraquezas e tráfes, senão ficarei vulnerável.
05. Não vou sentir e expressar emoções, pois é sinal de fraqueza.

B. Desencadeadoras de reações autodefensivas de ataque:

06. Devo me defender das pessoas hostis, pois se eu deixar vão querer prevalecer sobre mim de alguma forma.

07. Devo me defender de qualquer tentativa de denegrir a minha imagem ou dignidade.

08. Devo tratar da mesma forma quem não me considera ou me destrata.

09. Os outros devem reconhecer o meu valor e ter opinião positiva sobre mim.

10. Permitir que me inferiorizem é sinal de fraqueza.

3.3. Valores Anacrônicos e Conflitos de Valores.

Reciclagem. Apesar de serem mais estáveis ao longo do tempo, os valores podem ser modificados e, em tese, a reciclagem intraconsciente resulta na mudança, para melhor, de algum aspecto do sistema de valores pessoais.

Identificação. A análise crítica dos valores pessoais consiste em, previamente, identificá-los, inclusive aqueles patológicos, anacrônicos (desatualizadas) para o momento evolutivo ou mal aplicados.

Desencadeantes. Eis, por exemplo, obtidos a partir da casuística apresentada no registro autopsíquico, 6 valores patológicos ou anacrônicos aplicados de modo negativos nas autovivências, desencadeadores da belicopensidade autodefensiva:

1. (Defender a) **Dignidade.**

2. (Defender a) **Honra.**

3. (Fazer) **Justiça.**

4. (Manter o) **Poder.**

5. (Merecer) **Privilégio.**

6. (Obter) **Reconhecimento.**

Conflitologia. A casuística mostra o conflito entre o valor da interassistencialidade e a necessidade de manter algum tipo de poder anacrônico.

3.4. Técnica da Qualificação da Intenção.

Agressão. Genericamente, o comportamento agressivo, físico ou verbal, visa o prejuízo, a destruição ou derrota do outro ou, em alguns casos, de si próprio, podendo também estar a serviço da imposição da própria vontade, da aquisição de poder ou do restabelecimento da autoestima ferida, motivado por vingança.

Técnica. Para investigação das intenções anticosmoéticas mobilizadoras da belicopensidade autodefensiva, pode-se aplicar a *técnica da qualificação da intenção* em situação real, respondendo às 3 perguntas-chave: Por quê? Para quê? Para quem?

Caso selecionado:

Tabela 2. Registro dos autopsíquicos.

Situação	Pensamentos antagônicos	Emoções / sentimento	Energias / comportamentos	Materpensene
O professor chama minha atenção em frente a todos na sala de aula.	Ele está me humilhando ao falar assim comigo na frente de todos. Não vou aceitar isso.	Vergonha, raiva.	Dissimula a vergonha, assume posição pensônica defensiva e discorda do professor com agressividade.	Desrespeito.

Por quê? (Causa)

- **Por que dissimular a vergonha?** Pois assumir a vergonha significaria admitir a falha pessoal e não se deve mostrar abertamente erros, fraquezas e trafores, pois se torna vulnerável.
- **Por que assumir postura defensiva?** Pois o comportamento alheio foi percebido como um ataque, do qual deve defender-se.
- **Por que discordar com agressividade?** Devido ao sentimento de raiva, e isso significa que se deve reagir nestas condições (raciocínio emocional), senão será atingido. Existe a crença regressiva de que o ataque é a melhor defesa.

Para quê? (Finalidade)

- **Para que dissimular a vergonha?** Para acobertar uma emoção negativa que supostamente denigre a imagem que procura passar.
- **Para que assumir postura defensiva?** Para se defender do ataque à autoimagem e sentir-se seguro.
- **Para que discordar com agressividade?** Para impor respeito, para revidar, não se deixar ser rebaixado e se sentir fortalecido.

Para quem? (Conscin-alvo)

- **Para quem dissimular a vergonha?** Para as pessoas presentes que, supostamente, estão atentas com o intuito de ver alguma vulnerabilidade. Para si mesmo, pois assim diminui o autoconflito.
- **Para quem assumir postura defensiva?** Para si próprio, pois assim diminui o autoconflito.
- **Para quem discordar com agressividade?** Visando o suposto atacante e a si mesmo, pois assim diminui o autoconflito.

Minimização. A identificação dos pseudoganhos ajuda a minimizar a resistência pessoal às mudanças que mantém a consciência no padrão anterior. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 10 pseudoganhos da manutenção do padrão de manifestação analisado até o momento:

01. **Alívio.** Aliviar a tensão causada pelo sentimento de raiva.
02. **Antivitimização.** Impedir que outros inferiorizem ou vitimizem.
03. **Domínio.** Manter-se na posição de domínio ou, pelo menos, de igualdade.
04. **Força.** Sentir-se macho, forte e corajoso.
05. **Justiça.** Fazer justiça e obter o que merece.
06. **Opinião.** Mostrar o valor da opinião pessoal.
07. **Orgulho.** Sentir prazer e satisfação com a própria inteligência ou valor.
08. **Respeito.** Obter o respeito das outras pessoas.
09. **Retaliação.** Revidar a ofensa.
10. **Segurança.** Sentir-se mais seguro.

Resposta. A identificação das distorções cognitivas, crenças regressivas, valores anacrônicos e patológicos e a análise da intencionalidade fornecem as respostas para a primeira e a segunda questão da problematização. Neste caso, tal detalhamento do autodiagnóstico já representa o início do autoenfrentamento, o qual, junto com a superação, será abordado nas seções seguintes.

IV. PARATERAPÊUTICA

4.1. *Técnicas de Assertividade.*

Controle. O controle ou o manejo da agressividade por meio de *técnicas de comunicação assertiva* foi aplicado para auxiliar na redução dos possíveis danos causados nas interlocuções com as consciências em geral.

Recéxis. Tais técnicas ainda não abordaram diretamente as causas intraconscienciais do problema, contudo foram procedimentos etológicos de reciclagem existencial, com potencial de reduzir bastante os efeitos negativos causados pela expressão da agressividade, sobretudo nas interlocuções.

Autoprescrições consciencioterápicas:

1. Autorrespeito. Expressão direta dos próprios sentimentos, necessidades, direitos legítimos ou opiniões.

2. Heterorrespeito. Porém, sem ameaçar ou castigar os demais e sem violar os direitos alheios.

3. Passos. Caballo (2012) cita diferentes técnicas para serem aplicadas em contextos diversos, muitas das quais consistem em descrever heterocomportamento, tendo em vista os 3 passos a seguir:

- Expressar emoções pessoais de modo não agressivo.
- Especificar a mudança de comportamento desejada.
- Mostrar as consequências positivas de tal mudança.

4.2. *Técnica da Reestruturação Pensênica.*

Objetivo. Neste caso específico, a *técnica da reestruturação pensênica* foi aplicada para refutar as distorções cognitivas e as crenças regressivas que sustentam a manifestação patopensênica, auxiliando no ajuste das avaliações distorcidas da realidade, de fatos e parafatos.

Modulação. Na Enciclopédia da Conscienciologia (2013), Ruy Bueno ressalta a importância do sistema de crenças pessoais na atribuição de significados aos fatos e parafatos para a modulação das respostas de enfrentamento.

Conscienciologia. A refutação da patopensenização é realizada com base nos conceitos cosmoéticos e evolutivos do paradigma consciencial, tendo, entre outros, o potencial de reduzir a percepção de, insistentemente, perceber as heteromanifestações como se fossem movidas por intenções de ataque.

Autoprescrições consciencioterápicas:

1. Autoinvestigação. Identificação das distorções cognitivas e crenças regressivas.

Ex: raciocínio emocional (o que sente é considerado verdade).

2. Autovigilância. Contrapor os autopensenes na hora que aparecem, já tendo elaborado a forma cosmoética de reagir e se comportar quando a situação ocorre.

3. Autoquestionamentos. Aplicar a si mesmo questionamentos refutadores com base no paradigma consciencial.

- O fato de sentir raiva de alguém sempre significa que a pessoa alvo da emoção visa o ataque ou isso pode ser apenas resultado da interpretação pessoal distorcida?
- É justificável tratar agressivamente outra conscin?
- Na opinião pessoal, quais seriam as posturas cosmoéticas ante a experiência do sentimento de raiva?

- Qual a melhor forma de tratar a conscin que desencadeia este sentimento em si? Como se fossem potenciais ameaças ou na condição de assistidos (evolucionistas)?
- É possível que tal emoção seja potencializada por uma consciex patológica? O que fazer neste caso?

4.3. Praxioterapia.

Objetivo. A autoconsciencioterapia a partir do sistema de valores conscienciais consistiu em buscar viver de acordo com os próprios valores evolutivos, reciclar os anacrônicos, descartar os patológicos e reperspectivar a escala de valores pessoais (Haymann, 2016).

Conhecimento. Por exemplo, no caso deste autor, “conhecimento” já era um valor evolutivo importante e, em certo nível, priorizado na vivência. Deste modo, ele pôde ser mais prontamente reperspectivado e qualificado para auxiliar na paraterapêutica dos *efeitos antifraternos* da belicopense-nidade.

Foco. A análise das reações e interesses intelectuais mostraram que o foco pessoal na busca do conhecimento estava mais direcionado para o entendimento das ideias, no geral, quando comparado à compreensão das consciências, de modo mais específico.

Megaprioridade. Tal desvio se contrapõe ao princípio basilar da Conscienciologia de que a consciência é a realidade mais importante e complexa existente do Universo, sendo, dessa forma, sua compreensão a megaprioridade cognitiva de quem possui alguma inteligência evolutiva. *O desinteresse pelas consciências é sinal inequívoco de ignorância evolutiva.*

Bloqueio. A reação emocional, no caso raivosa, agressiva e autodefensiva a qualquer tipo de comportamento consciencial, bloqueia o movimento evolutivo da intercompreensão, tanto pela ofuscação do autodiscernimento quanto pelos demais processos patológicos já apresentados.

Cosmoética. O objetivo da reperspectivação da aplicação teática do valor *conhecimento* não é abordar as consciências visando *conhecê-las* tão somente para se obter algum fim egocêntrico, mas de interesse genuíno, real conquista evolutiva, como meio catalisador da intercompreensão e, consequentemente, da fraternidade, pois como afirma Vieira (2014): “O autodiscernimento e a compreensão vêm, e precisam vir, antes da afetividade”; “Fraternidade: amor mais compreensão”.

Efeito. Na prática, esta reestruturação cognitiva, mesmo que inicial já modifica a forma de avaliar as manifestações das outras consciências. O próximo passo, para a fixação do novo mote do valor, é a repetição da postura homeostática nas relações cotidianas.

CPC. A constituição de cláusulas específicas para o *código pessoal de Cosmoética* que auxiliem na reformulação do sistema de valores pessoais é técnica complementar de grande valia neste caso.

4.4. Técnica do Acolhimento.

Objetivo. O objetivo da técnica foi desenvolver a fraternidade e a postura pessoal acolhedora nas interações conscienciais por meio da prática do acolhimento auto e heteroterapêutico.

Autoprescrições consciencioterápicas:

1. Simpatia. Adotar comportamentos (recéis), em geral, simpáticos às pessoas: sorrir; cumprimentar; assumir posturas corporais receptivas; interessar-se pelos assuntos alheios.

2. Empatia. Adotar condutas empáticas, identificando e afinizando-se de modo não julgador com pensamentos, emoções e ECs alheias, demonstrando holossomaticamente interesse e busca da compreensão.

3. Acolhimento. Colocar-se em postura acolhedora *full time*, principalmente em situações e com pessoas consideradas de alguma forma ameaçadoras.

V. DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO FRATERNA

Desenvolvimento. As abordagens paraterapêuticas apresentadas na seção anterior objetivam a redução ou mesmo a remissão da belicopensenidade, porém também apresentam como objetivo o fortalecimento da compreensão fraterna.

Conjunto. A compreensão fraterna se consolida na intraconsciencialidade por meio da conquista e fixação de um conjunto de traços ou características homeostáticas, antípodas àquelas manifestadas quando entra em ação o mecanismo da belicopensenidade autodefensiva.

Fixação. Para auxiliar na fixação destes traços na automanifestação recorreu-se a uma adaptação da *técnica do meganível da autoconsciência*, proposta por Vieira (2013), aqui denominada *técnica da neoconcepção autoconsciencial*, descrita a seguir:

5.1. Técnica da Neoconcepção Autoconsciencial.

Derivação. A *técnica do meganível da autoconsciência* é o procedimento no qual a conscin lúcida, homem ou mulher, pessoa adulta, coloca-se, no estado da vigília física ordinária, imaginativamente, na condição da autovivência regular da consciência intrafísica do ser desassediado, permanente, total, ou desperto, já distante da consciencialidade dos pré-serenões vulgares.

Adaptação. Na adaptação da técnica o objetivo é o evoluciente colocar-se imaginativamente na condição antagônica positiva à da parapatologia a ser superada, focando-se no novo ego homeostático almejado, o qual deseja manifestar a partir de então.

Teática. Aplicada à belicopensenidade autodefensiva, ao invés de manter a conduta armada defensiva ou reativa agressiva, a conscin busca a vivência teática, regular, de compreensibilidade fraterna, notadamente nos contextos nos quais reconhece a tendência pessoal da reatividade regressiva.

Comparativo. Eis, por exemplo, tabela comparativa entre 12 características patológicas da conscin de conduta armada e 12 características homeostáticas de compreensibilidade fraterna a serem adotadas por meio da técnica neoconcepção autoconsciencial:

Tabela 3. Conduta Armada X Compreensibilidade Fraterna.

N	Características	Conduta Armada	Compreensibilidade Fraterna
01.	Afetividade	Raiva; aversão	Fraternidade; interesse
02.	Atitude	Bélica; hostil	Pacífica; receptiva
03.	Autodefesa	Patológica	Homeostática
04.	Companhias	Guias cegos; assediadores	Amparadores; assistidos
05.	Comunicologia	Argumentação agressiva	Escuta empática; assertividade
06.	Fisionomia	Sorriso raro; sobrelenho fechado	Sorriso fácil; descontração
07.	Força presencial	Intimidadora; repulsora; pesada	Acolhedora; aglutinadora; leve
08.	Heteroabordagem	Preconceituosa; acepação de pessoas	Compreensiva fraterna; benevolente
09.	Heteroconcepção	Inimigo; competidor	Assistido; evoluciente
10.	Humor	Seriedade excessiva	Bom humor habitual
11.	Intencionalidade	Imposição da vontade	Heterocompreensão; respeito
12.	Valor vivenciado	Poder	Consciência; interassistência

VI. INDICADORES DE AUTOSSUPERAÇÃO

Taxologia. Eis, a seguir, na ordem alfanumérica, 14 indicadores de autossuperação, dentre os quais 7 foram selecionados para mensurar os resultados dos autoenfrentamentos para a redução

da reatividade agressiva e outros 7 indicados para a avaliação da qualificação da vivência teática da compreensão fraterna:

A. Indicadores de redução de reações e de efeitos patológicos.

01. **Afastamento.** Afastamento de companhias extrafísicas patológicas, com presença menos frequente na psicosfera pessoal.

02. **Autolucidez.** Aumento da autolucidez quanto às minirreações associadas ao *modus operandi* anacrônico.

03. **Conflitos.** Redução do envolvimento pessoal em situações conflituosas.

04. **Autodefesa.** Arrefecimento das autodefesas patológicas.

05. **Frequência.** Redução da frequência da manifestação reativa.

06. **Incomodação.** Redução do incômodo gerado pela interação com outras consciências com reações patológicas similares às dela própria.

07. **Sutilezas.** Autoconstrangimento pela percepção de novas sutilezas da própria manifestação patológica, agora conscientemente evitada, ao modo destes 5 exemplos:

- Acepção de pessoas.
- Desconexão afetiva como forma de retaliação.
- Ironia quanto ao comportamento alheio.
- Pequenas condutas punitivas.
- Preconceito velado.

B. Indicadores de qualificação da compreensão fraterna.

08. **Amizade.** Aprofundamento das amizades e dos vínculos afetivos.

09. **Aproximação.** Maior aproximação de pessoas; aumento da aglutinação.

10. **Expressão.** Expressão desreprimida de emoções e afetos positivos.

11. **Fraternidade.** Sensação espontânea de maior interesse e afetividade pelas consciências.

12. **Heterocompreensão.** Maior compreensão das manifestações alheias, notadamente daquelas patológicas.

13. **Heterofeedback.** Aumento da frequência do recebimento de *heterofeedbacks* positivos.

14. **Humor.** Qualificação do nível médio do humor pessoal.

VII. CONCLUSÃO

Resultados. A experimentação dos indicadores de autossuperação confirmam que a vivência do processo autoconsciencioterápico e as respectivas técnicas aplicadas vêm resultando em importantes autorreciclagens.

Autoenfrentamento. Ainda é necessário maior detalhamento das distorções cognitivas, das crenças e intenções anticosmoéticas associadas à parapatologia, bem como a ampliação da reestruturação pensênica com base nos princípios do paradigma consciencial. Contudo, o caso já se encontra, predominantemente, na fase autoenfrentamento.

Patopensenidade. Os problemas identificados relacionados ao poder e belicismo suportam haver outros tipos de patopensenidades a serem tratadas, por exemplo: além da raiva, tais problemas denotam evidências de emoções negativas de aversão e orgulho.

Manifestação. Outro aspecto a ser considerado é o fato de a belicopensenidade ser apenas um viés da manifestação dos autoassédios latentes identificados, os quais também podem ser expressos, por exemplo, por meio da manipulação e da sedução energossomática, conforme abordado na introdução.

Tarefas. Eliminar a raiva, a irritabilidade e quaisquer resquícios de autobelicismo da intraconsciencialidade é tarefa de grande importância evolutiva, contudo ainda mais relevante é consolidar um ego verdadeiramente compreensivo, fraterno e interassistencial. A primeira tarefa é requisito indescartável para se alcançar a segunda, embora ambos desafios possam ser enfrentados simultaneamente.

REFERÊNCIAS

01. Beck, Aaron T.; Freeman, Arthur; Davis, Denise D.; & Colaboradores; *Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade* (*Cognitive Therapy of Personality Disorders*); revisor Cristiano Nabuco de Abreu; trad. Maria Adriana Verissimo Veronese; 342 p.; 16 caps.; 415 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2005; página 321.
02. Bello, Amy; *Reciclagem Intraconsciencial de Megatrafar Autocrata-Belicista: Um Relato Pessoal*; Artigo; *Proceedings of the 6th Consciential Health Meeting and 4th Symposium on Self-Conscientiotherapy*; Evoramonte, Portugal; 22-24.10.10; *Journal of Conscientiology*; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 50-S; 1 cronologia; 15 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 11 refs.; *International Academy of Consciousness* (IAC); London; UK; October, 2010; páginas 11 a 35.
03. Caballo, Vicente E.; *Manual de Avaliação e Treinamento de Habilidades Sociais* (*Manual de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales*); tradução Sandra M. Dolinsky; XVI + 408 p.; 7 caps.; 5 apênds.; alf.; 727 refs.; 24 x 17 cm; br.; Livraria Santos; São Paulo, SP; 2012; páginas 241 a 288 e 360 a 365.
04. Haymann, Maximiliano; *Identificação do Ciclo do Autassédio: Técnica para Aumento da Efetividade Autoconsciencioterápica*; VIII Jornada de Saúde da Consciência e VII Simpósio de Autoconsciencioterapia; Artigo; *Saúde Consciential*; Revista; Anual; Vol. 3; N. 3; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro, 2014; páginas 99 a 108.
05. Idem; *Prescrições para o Autodesassédio*; revisores Ivelise Vicenzi; et al.; 216 p.; 4 seções; 36 caps.; 24 E-mails; 88 enus.; 1 esquema; 1 fluxograma; 1 foto; 1 microbiografia; 4 tabs.; 21 websites; glos. 168 termos; 63 refs.; 28 webgrafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 70 a 81 e 143 a 147.
06. Lipp, Marilda Emmanuel Novaes & Malagris, Lucia Emmanuel Novaes; *O Treino Cognitivo de Controle da Raiva: O Passo a Passo do Tratamento*; prefácio Bernard Rangé; 140 p.; 7 caps.; 2 anexos; 75 refs.; 21 x 15 cm; br.; Cognitiva; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 35 a 37, 102 e 103.
07. Vieira, Waldo; *Enciclopédia da Conscientiologia Digital*; 11.034 p.; glos. 2.498 termos (verbetes); 192 microbiografias; 147 tabs.; 191 verbetógrafos; 8ª Ed. Digital; Versão 8.00; Associação Internacional Editares; & Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscientiologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 637 a 641 (Antagonismologia patológica); 941 a 945 (Arrogância); 3086 a 3091 (Conduta desarmada); 3902 a 3904 (Descarte dos resquícios); 4145 a 4148 (Distorção cognitiva); 4791 a 4798 (Estratégias de enfrentamento); 7041 a 7043 (Meganível da autoconsciência) e 9475 a 9477 (Repetição paciente).
08. Idem; *Léxico de Ortopensatas*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.800 p.; glos. 6.476 termos (verbetes); 20.800 ortopensatas; 1.811 megapensenes trivocabulares; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 715 e 1416.
09. Idem; *Homo sapiens pacificus*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscientiologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 256 e 299.
10. Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; *Terapia do Esquema: Guia de Técnicas Cognitivo-Comportamentais Inovadoras* (*Schema Therapy*); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10 caps.; 104 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; página 321.